

Statut vitaminique et pathologies neurovasculaires : étude des concentrations des vitamines B9, B12 et D

ADIMI.M(1), OUNNOUGHI.C(1), KENDRI.S (1), DJABI.F (1)

(1) CHU Sétif, Laboratoire central de biologie

Introduction

Les vitamines B9, B12 et D jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du système nerveux et l'intégrité vasculaire. Les vitamines B9 et B12 participent au métabolisme de l'homocystéine, dont l'élévation constitue un facteur de risque reconnu des maladies cérébrovasculaires, tandis que la vitamine D exerce des effets neuroprotecteurs, immunomodulateurs et anti-inflammatoires. Le dosage de ces vitamines est fréquemment demandé dans le bilan étiologique des accidents vasculaires cérébraux (AVC), des thromboses veineuses cérébrales (TVC), des neuropathies périphériques, des paresthésies, des troubles cognitifs et de certaines anémies d'origine neurologique. L'objectif de cette étude était d'évaluer le statut vitaminique des patients explorés dans un contexte de pathologies neurovasculaires.

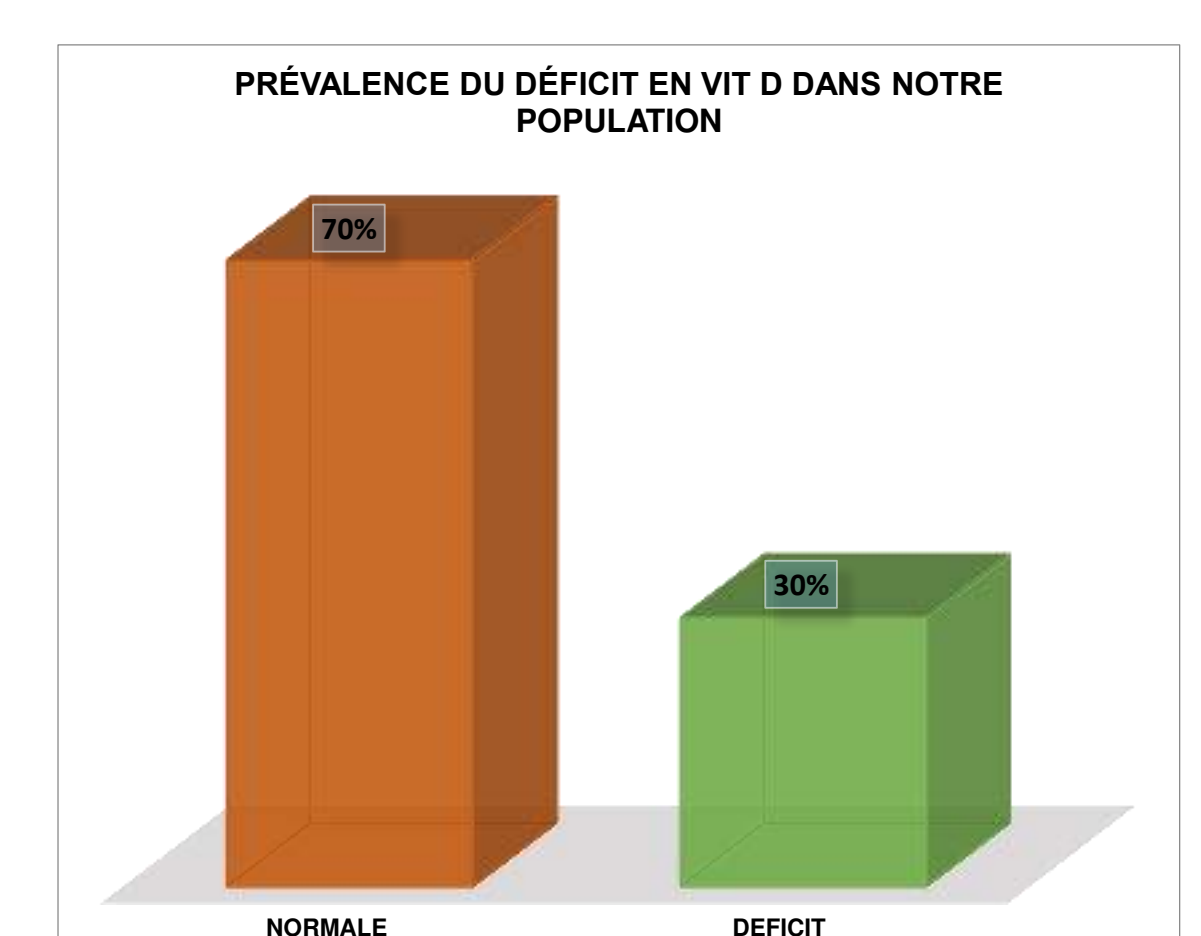
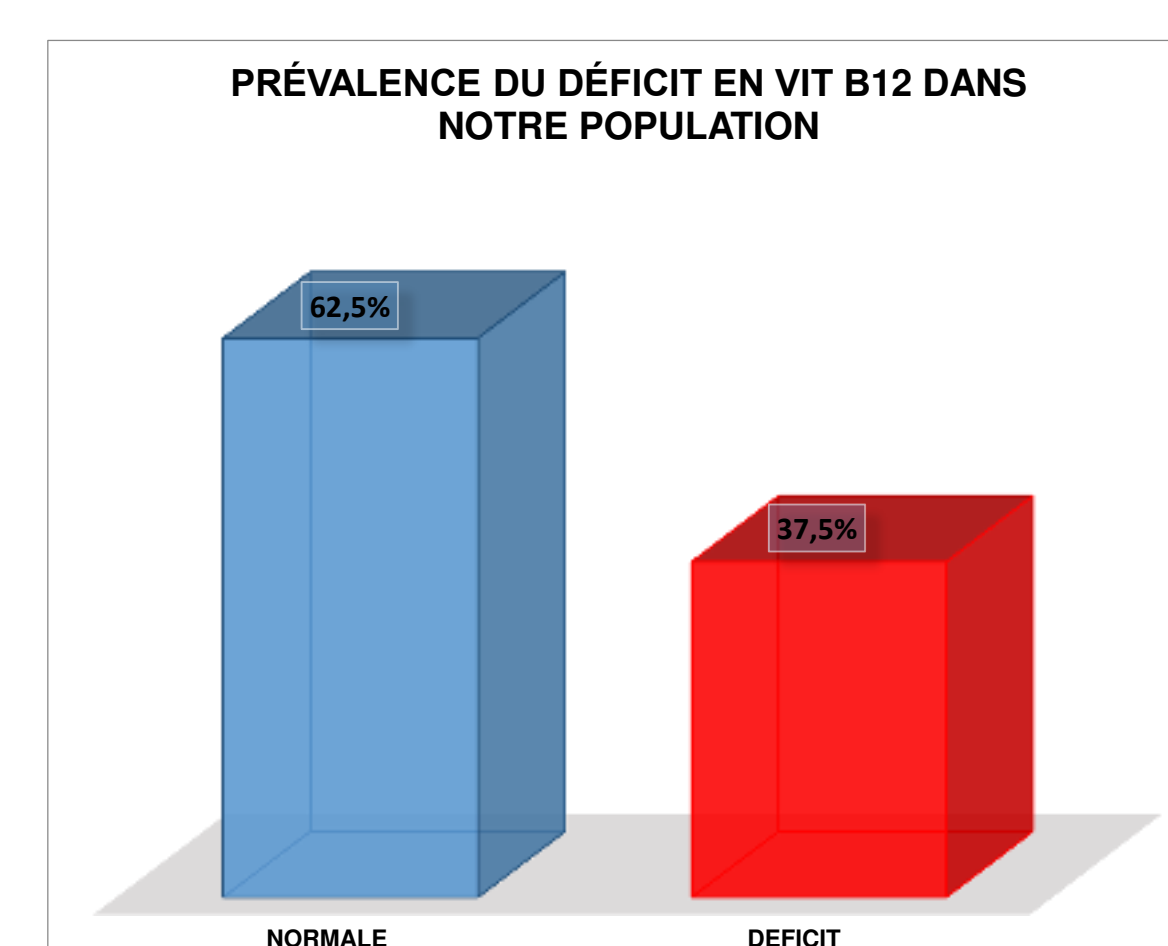
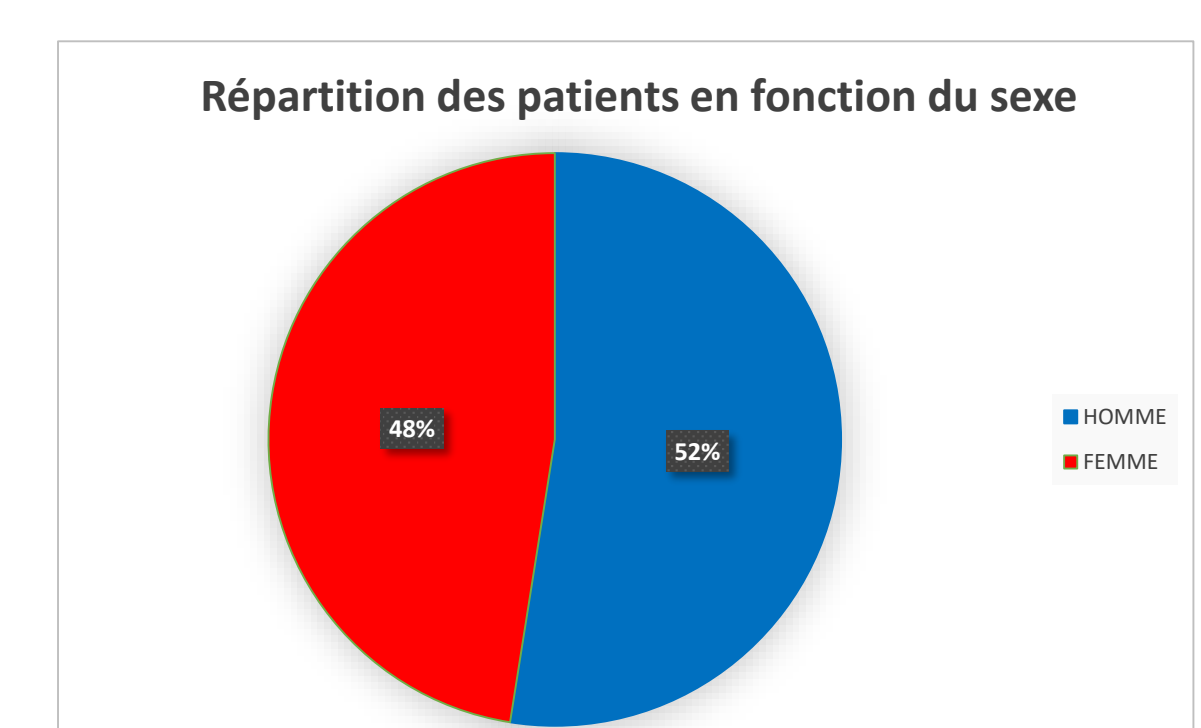
I. Matériel et méthode

- ✓ Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective réalisée au laboratoire de biochimie du CHU de Sétif.
- ✓ 40 patients ayant bénéficié d'un dosage de la vitamine B9, de la vitamine B12 et/ou de la vitamine D dans le cadre d'une exploration de pathologies neurovasculaires ou de manifestations neurologiques ont été inclus.
- ✓ Les données recueillies comprenaient l'âge, le sexe, l'indication clinique (AVC ischémique, AVC hémorragique, thrombose veineuse cérébrale, paresthésies, neuropathies, anémie ou autres) ainsi que les concentrations des vitamines dosées.
- ✓ Les déficits vitaminiques ont été définis selon les valeurs de référence du laboratoire.

III. Discussion

La fréquence des déficits en vitamines B9 et D observée dans cette étude souligne l'intérêt de leur évaluation biologique chez les patients présentant une pathologie neurovasculaire. Le déficit en folates peut favoriser l'hyperhomocystéinémie, reconnue comme facteur de risque vasculaire, alors que l'insuffisance en vitamine D est de plus en plus associée à une augmentation du risque d'AVC et à un moins bon pronostic neurologique. La faible prévalence de la carence en vitamine B12 suggère que son dosage devrait être orienté par le contexte clinique. Les limites de cette étude résident dans son faible effectif et son caractère descriptif.

II. Résultats



IV. Conclusion

Les déficits en vitamines B9 et D sont relativement fréquents chez les patients explorés pour des pathologies neurovasculaires, contrairement à la carence en vitamine B12, qui apparaît plus rare. Le dépistage ciblé de ces anomalies pourrait contribuer à une meilleure prise en charge des patients. Des études analytiques incluant des effectifs plus importants sont nécessaires afin de préciser l'impact de ces déficits sur la survenue et l'évolution des maladies neurovasculaires.